

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 13

Lavage Des Mains



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

INTRODUCTION

L'hygiène des mains constitue une arme simple, efficace et capitale pour la prévention de la transmission par manuportage des agents infectieux. Elle contribue à limiter la transmission manuportée d'agents infectieux :

- 🧼 Du patient au soignant,
- 🧼 Du soignant au patient,
- 🧼 De l'environnement au patient ou au soignant.

En effet, elle est étroitement liée au risque infectieux et à la transmission croisée de bactéries résistantes, c'est une procédure critique parfois sous-estimée et négligée.

Indications du lavage des mains

- 🧼 Avant de toucher un patient ;
- 🧼 Avant un geste aseptique ;
- 🧼 Après l'exposition à un liquide biologique ;
- 🧼 Après avoir touché un patient ;
- 🧼 Après avoir touché l'environnement d'un patient.

Les deux premières indications s'appliquent avant un contact ou une procédure de soins, soulignent la nécessité de prévenir tout risque de transmission microbienne au patient. Les trois autres s'appliquent après un contact ou une exposition à des liquides biologiques, visent à prévenir les risques de transmission microbienne au personnel soignant et dans l'environnement de soins.

En effet, une bonne hygiène des mains, surtout chez les professionnels de santé, participe pleinement de cet objectif. **80%** des micro-organismes se transmettent par les mains, ce qui amène l'OMS à estimer que **40%** des infections associées aux soins sont manuportées.

Le lavage simple

TEMPS PRÉVU DE RÉALISATION : 30 secondes.

OBJECTIFS :

- 🧼 Éliminer les souillures et prévenir les contaminations.
- 🧼 Réduire la flore transitoire.

INDICATIONS :

- 🧼 En arrivant et en quittant le service.
- 🧼 Après tout geste de la vie courante.
- 🧼 Lors de soins infirmiers non invasifs.
- 🧼 Après avoir manipulé des objets ou matériels souillés.

MATÉRIEL :

- 🧼 Point d'eau.
- 🧼 Distributeur de savon liquide (bactériostatique).
- 🧼 Essuies mains à usage unique.
- 🧼 Poubelle à pédale (hygiénique).

DÉROULEMENT

- 🧼 Mouiller les mains et les poignets.
- 🧼 Recueillir une dose de savon.
- 🧼 Frotter les mains pendant 15 secondes en insistant sur les espaces interdigitaux, le dos de la main, les ongles, le bord cubital, et les pouces.
- 🧼 Rincer soigneusement en positionnant les mains plus hautes que les coudes : même durée que le temps de savonnage.
- 🧼 Sécher par tamponnement avec des essuies mains en allant des doigts vers les poignets.
- 🧼 Refermer le robinet avec le dernier essuie main utilisé.
- 🧼 Jeter l'essuie main dans la poubelle sans la toucher avec la main.

Procéder à un lavage simple des mains avant de porter des gants à usage unique.

Le lavage antiseptique

TEMPS PRÉVU DE RÉALISATION : 1 minute.

OBJECTIF :

- 🧼 Éliminer la flore transitoire.
- 🧼 Réduire la flore résidente.

INDICATIONS :

- 🧼 Lors de la mise en place de mesure d'isolement septique ou aseptique.
- 🧼 Après deux séquences de soins à risque de contamination chez un même patient ou entre deux patients.
- 🧼 Après tout contact avec un objet ou du linge potentiellement contaminé ;
- 🧼 Après tout contact avec un patient infecté ou porteur d'une bactérie multi-résistante ou avec son environnement ;
- 🧼 Avant tout contact avec un patient immunodéprimé ;
- 🧼 Avant toute manipulation de dispositifs médicaux (pinces à pansement, aérosol...) ;
- 🧼 Avant la réalisation d'un geste invasif ;
- 🧼 En cas de succession de gestes contaminant pour le même patient ;
- 🧼 Après tout contact accidentel avec du sang ou des liquides biologiques.

MATÉRIEL :

- 🧼 Point d'eau.
- 🧼 Distributeur de savon liquide (antiseptique).
- 🧼 Essuies mains à usage unique.
- 🧼 Poubelle à pédale (hygiénique).

DÉROULEMENT :

Les mêmes étapes que le lavage simple, sauf que :

- 🧼 Utiliser un savon antiseptique.

- 🧼 Savonner les mains jusqu'au coude et allonger le temps de savonnage.
- 🧼 Rincer abondamment en faisant couler l'eau de l'extrémité des doigts jusqu'au coude.
- 🧼 Sécher de la même manière.

Traitement hygiénique des mains par friction

TEMPS PRÉVU DE RÉALISATION : 30 à 60 secondes.

OBJECTIF :

- 🧼 Eliminer la flore transitoire et diminuer la flore commensale.

INDICATION :

- 🧼 Immédiatement avant tout contact direct avec un patient ;
- 🧼 Avant tout soin propre ou tout acte invasif ;
- 🧼 Entre un soin contaminant et un soin propre ou un acte invasif chez un même patient ;
- 🧼 Après le dernier contact direct ou soin auprès d'un patient ;
- 🧼 Avant d'enfiler des gants pour un soin ;
- 🧼 Immédiatement après avoir retiré des gants.

MATÉRIEL :

- 🧼 Solution hydro-alcoolique. (Ne pas utiliser d'eau, ni d'essuie mains).

DÉROULEMENT :

- 🧼 Vérifier que les mains sont sèches, sans souillures, sans talc.
- 🧼 Saisir une dose de solution hydroalcoolique l'étaler largement par friction (environ 30 secondes) jusqu'à évaporation spontanée du produit au contact de l'air : paume contre paume, paume contre le dos de la main, espaces interdigitaux, ongles, pouces, poignets, bord cubital.
- 🧼 Effectuer un lavage simple des mains chaque fois que les mains portent une souillure visible et également après plusieurs applications successives de solution hydroalcoolique.

Le lavage chirurgical

TEMPS PRÉVU DE RÉALISATION : 6 minutes.

OBJECTIF :

- 🧼 Éliminer la totalité de la flore transitoire
- 🧼 Une grande partie de la flore résidente.

INDICATION :

- 🧼 Il est réservé au bloc opératoire et aux gestes invasifs à hauts risques.

MATÉRIEL :

- 🧼 Eau stérile, savon antiseptique.
- 🧼 Brosse à ongles stérile à usage unique, essuie-mains stériles.

DÉROULEMENT :

Procéder en trois temps :

1^{er} temps : prélavage

- 🧼 Mouiller les mains, les poignets et avant-bras jusqu'aux coudes.
- 🧼 Appliquer une dose de savon antiseptique et faire mousser abondamment par massage de l'extrémité des doigts, jusqu'aux coudes pendant 1 minute.
- 🧼 Maintenir toujours les mains au-dessus des coudes pendant toute l'opération.
- 🧼 Rincer abondamment les mains, les poignets et avant-bras.

2^e temps :

- 🧼 Brosser les ongles avec la brosse stérile imprégnée de solution moussante antiseptique pendant 1 minute.
- 🧼 Rincer abondamment les mains, les poignets et avant-bras.

3e temps :

- ☼ Reprendre une dose de savon, masser pendant 1 minute (mains, poignets, avants bras) puis rincer.
- ☼ Sécher par tamponnement avec un essuie-mains stérile à usage unique, un par membre, en allant des mains vers les coudes, en maintenant les mains vers le haut Jusqu'à l'habillage.

CRITÈRES DE QUALITÉ DE LA TECHNIQUE DU SOIN :

- ☼ Equipement correct des postes de lavage des mains : présence de savon liquide antiseptique et bactériostatique, d'essuie-mains à usage unique, poubelle sans fermeture manuelle.
- ☼ Ongles courts, absence de port de faux ongles, de bijoux et de montre et avant-bras nus.
- ☼ Utiliser du savon adéquat par rapport à l'acte de soin à réaliser.
- ☼ Respect du temps de lavage des mains en fonction du type de lavage.
- ☼ Mains et avants bras secs après essuyage.

Flore résidente : une flore qui vit et se multiplie dans les couches superficielles de la peau. Elle est essentiellement constituée de corynébactéries, de staphylocoagulases négatives et bactéries anaérobies (ex *Propionibacterium acnés*).

Flore transitoire/transitaire : une flore acquise par le soignant tout au cours de son activité. Elle dépend de l'environnement et de l'activité du sujet. La survie des micro-organismes est habituellement transitoire mais elle peut remplacer la flore naturelle résidente surtout si la peau est irritée ou lésée. Elle est en partie constituée de germes potentiellement pathogènes : *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas*, entérobactéries, streptocoques.

Types et indications de port de gants

1/ Gants non stériles à usage unique :

- ❖ Chaque fois qu'il y a un risque de contact avec :
 - ✓ Du sang ou tout autre produit biologique
 - ✓ Une peau lésée ou une muqueuse
 - ✓ Du linge ou du matériel souillé
- ❖ Lors des soins, chaque fois que le soignant présente une lésion cutanée au niveau des mains.

2/ Gants stériles à usage unique :

- ❖ Pour tous les gestes nécessitant un haut niveau d'asepsie
- ❖ Pour toute manipulation de produits et de matériels stériles.

Les masques

Masque à usage unique :

Le port du masque à usage unique n'est efficace que si les précautions suivantes sont respectées, à savoir :

1. Changer le masque toutes les 3 h et dès qu'il est mouillé ou souillé
2. Oter le masque dès la fin du soin
3. Eliminer le masque dans le circuit des DASRI
4. Réaliser une friction hydro-alcoolique des mains

Types de masque :

Il existe deux grandes catégories de masques

1/ Les masques médicaux :

- ❖ Les masques de soin (ou masques chirurgicaux) sont destinés à éviter la projection de gouttelettes de salive ou de sécrétions respiratoires lors de l'expiration du soignant vers le patient ou d'un malade contagieux vers son entourage.

- ❖ Les masques antiprojections (comportent une couche imperméable, et parfois une visière) peuvent assurer en plus la protection du soignant contre les projections de liquide provenant du patient au cours d'un acte de soins ou de chirurgie.

Les masques médicaux ne protègent pas leur porteur vis à vis de l'inhalation de particules infectieuses.

2/ Les masques de protection respiratoire jetables :

Sont destinés à protéger celui qui le porte contre l'inhalation de poussières et /ou l'aérosols contaminés par des agents infectieux transmissibles par voie aérienne.

Il existe trois classes d'efficacité : **FFP1**, **FFP2**, **FFP3** selon la norme EN 149

- 1.** Les masques **FFP1**, filtrant au moins **80%** des aérosols de taille moyenne de 0.6 micromètres ; (Fuite totale vers intérieur inférieur à **22%**)
- 2.** Les masques **FFP2**, filtrant au moins **94%** des aérosols de taille moyenne de 0.6 micromètres ; (Fuite totale vers intérieur inférieur à **08%**)
- 3.** Les masques **FFP3**, filtrant au moins **99%** des aérosols de taille moyenne de 0.6 micromètres ; (Fuite totale vers intérieur inférieur à **02%**)